UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

NEUROCHIRURGIE
Diagnostic et prise en charge d'une hydrocéphalie chronique
Avec patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Marie Le Pendu **Date de rédaction :** 8/01/2024

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 31 – Perte d'autonomie progressive

Domaine de compétence n°1 : Entretien/interrogatoire

Domaine de compétence n°2 : Stratégie de prise en charge

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1-Organiser son raisonnement et hiérarchiser les hypothèses diagnostiques

2-Prescrire de manière raisonnée les explorations complémentaires

Patient simulé nécessaire à la station : OUI HOMME 65 ans

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON

- **Feuille comprenant le TDM non injecté**

Exemple d'instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autre que ce qui est précisé.

Synopsis : Vous êtes Mr. Georges, âgé de 65 ans, retraité. Vous vous plaignez depuis plusieurs semaines d'incontinence urinaire, apparue progressivement, qui vous dérange dans votre vie quotidienne. Vous avez également remarqué l'apparition nouvelle de chutes. Vous avez consulté votre médecin traitant qui vous a redirigé en consultation avec un neurochirurgien.
Le neurochirurgien va vous interroger et faire la prise en charge sans réaliser d'examen clinique.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : GEORGES Prénom : ALAIN Âge : 65 ANS Retraité, ancien commercial Marié, 2 enfants de 37 et 40 ans Habite en appartement avec sa femme, en ville
Antécédents	Hémorragie méningée (mots simples : saignement dans la tête), il y a 6 mois
Médicaments actuels/ Toxiques	*Pas de tabac* *Alcool occasionnel*
Etats d'esprit/ comportement	Posture assise Absence de douleur Forte angoisse, incontinence urinaire source de gêne pour le patient Colère faible
Déroulement du scénario	Vous êtes assis Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *Bonjour, j'ai depuis quelques semaines l'apparition d'incontinence urinaire ainsi que de chutes. J'ai été voir mon médecin qui m'a redirigé vers vous.* Si le médecin demande **PRÉCISÉMENT** « le type, sous quel forme etc » se présente votre incontinence urinaire - Depuis 3 semaines - Urgenturie mictionnelle - Non aggravée par le rire ou l'effort

	Si le médecin demande **PRÉCISÉMENT** « le type de marche, fréquence de l'irrégularité de la marche, au demi-tour,) - Depuis 3 semaines - Marche à petits pas, instable, hésitante - Demi-tour décomposé Si le médecin demande **PRECISEMENT** « la présence de troubles de la mémoire remarqué par sa femme (sous forme de plaintes) ou lui-même, la présence de ralentissement psychomoteur remarqué par sa femme ou lui-même) - Répondre NON aux deux questions Si le médecin demande si il y a des antécédents, préciser l'hémorragie méningée il y a 6 mois correctement traitée. Si le médecin demande la présence de signes cliniques supplémentaires : céphalées, vomissements, troubles visuels - Répondre NON

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
A propos de votre **incontinence urinaire,** sous quelle forme se présente t-elle ? Depuis combien de temps ? Est-elle aggravée par le rire ou l'effort ?	Urgenturie mictionnelle = envie pressante 3 semaines NON
Est-ce qu'il y a une **incontinence fécale** associée ?	NON
A propos de vos **chutes** depuis combien de temps ? Avez- vous du mal à marcher ? Si oui, comment ? Au demi-tour également ?	3 semaines OUI A petits pas, hésitante OUI
Avez-vous remarqué vous ou votre femme, des troubles de la mémoire ou un ralentissement psychomoteur ?	NON
Avez-vous des ATCD ?	Hémorragie méningée il y a 6 mois, correctement traitée
Avez- vous d'autres signes cliniques ? (comprenant céphalées, troubles de vision, vomissements)	NON
Est-ce que ces signes sont apparus de façon progressive ?	OUI

Instructions à l'étudiant

Vous êtes Mr. JANVIER, neurochirurgien à l'Hôpital Michel et recevez Mr. GEORGES, patient de 65 ans, adressé en consultation par son médecin traitant pour apparition d'incontinence urinaire ainsi que de chutes depuis quelques semaines.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Faire un bref interrogatoire afin d'étayer votre hypothèse diagnostique, précisez-là
2. Demander l'examen complémentaire nécessaire, l'interpréter puis expliquer la prise en charge nécessaire au patient.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
Demande à l'interrogatoire la présence ou l'absence de céphalées, de vomissements, de troubles de la vision	
Précise le type d'incontinence urinaire (à l'effort ou par urgenturie)	
Demande si le patient présente des troubles de la marche associée à ses chutes	
Précise si l'apparition des symptômes est brutale ou progressive (temporalité)	
Demande à l'interrogatoire si le patient ou sa femme rapportent des troubles de la mémoire ou un ralentissement psychomoteur	
Précise que l'étudiant suspecte une hydrocéphalie chronique	
Tâche 2	
Demande la réalisation d'une tomodensitométrie cérébrale non injectée	
Précise que l'examen réalisé est une TDM cérébrale non injecté	
Précise que l'examen est compatible avec son hypothèse diagnostique	
Précise la présence de dilatations ventriculaires bilatérales	
Précise la présence de signes de résorption transépendymaires	
Précise la nécessité d'une dérivation interne du LCS	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à questionner	
Aptitude à faire la synthèse des données	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tâche 1	
Demande à l'interrogatoire la présence ou l'absence de céphalées, de vomissements, de troubles de la vision (1 point si 2/3 demandé)	1
Précise le type d'incontinence urinaire (à l'effort ou par urgenturie)	1
Demande si le patient présente des troubles de la marche associée à ses chutes	1
Précise si l'apparition des symptômes est brutale ou progressive (temporalité)	1
Demande à l'interrogatoire si le patient ou sa femme rapportent des troubles de la mémoire ou un ralentissement psychomoteur	1
Précise que l'étudiant suspecte une hydrocéphalie chronique	1
Tâche 2	
Demande la réalisation d'une tomodensitométrie cérébrale non injectée (1 point si 3/3 demandé)	1
Précise que l'examen réalisé est un TDM cérébrale non injecté (1 point si 3/3 demandé)	1
Précise que l'examen est compatible avec son hypothèse diagnostique	1
Précise la présence de dilatations ventriculaires bilatérales	1
Précise la présence de signes de résorption transépendymaires	1
Précise la nécessité d'une dérivation interne du LCS	1
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à questionner	Note de 0 ou 0,25 ou 0,5 ou 0,75 ou 1 par aptitude
Aptitude à faire la synthèse des données	